

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA PREVENZIONE VIOLENZA CONTRO GLI OPERATORI SANITARI

Area 12 – People

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO028_00	00	12/04/2026	7
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
P&C / RSPP / DS	AD – Francesco Epifani	Distribuito a tutto il personale	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Carolina Bussoletti	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le misure organizzative, strutturali e formative adottate da Toscana Diagnostica per prevenire gli atti di violenza, aggressione e molestia contro gli operatori sanitari e tutto il personale che opera a contatto con il pubblico. La procedura disciplina inoltre le modalità di gestione degli eventi di violenza qualora si verificano, garantendo la tutela dell'operatore, la corretta segnalazione, il supporto psicologico e il follow-up.

La procedura si applica a tutte le sedi di Toscana Diagnostica (laboratorio centralizzato, centri diagnostici, punti prelievo, sede amministrativa), a tutto il personale dipendente e ai collaboratori esterni che operano a contatto con i pazienti e i loro accompagnatori. La violenza contro gli operatori sanitari è un fenomeno in crescita che il legislatore ha affrontato con la Legge 113/2020, inasprendo le pene e introducendo l'obbligo per le strutture sanitarie di adottare misure di prevenzione. Toscana Diagnostica, pur operando in un contesto diagnostico ambulatoriale a rischio relativamente contenuto, intende affrontare il tema in modo sistematico e preventivo.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
L. 113/2020	Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni
D.Lgs. 81/2008, artt. 17-18, 28	Valutazione di tutti i rischi, incluso il rischio da aggressione; obblighi del datore di lavoro
Raccomandazione Min. Salute n. 8/2007	Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari
DGRT 1037/2019	Requisiti di accreditamento della Regione Toscana: sicurezza degli operatori
ISO 45001:2018, cl. 6.1, 8.1	Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli
ISO 7101:2023	Qualità e sicurezza nelle strutture sanitarie: ambiente sicuro per operatori e pazienti
PAS 24000:2022	Social Management: tutela della dignità e sicurezza dei lavoratori
TD-SGI-PRO007	Procedura sicurezza sul lavoro (DVR)
TD-SGI-PRO008	Procedura gestione emergenze (evacuazione, primo soccorso)
TD-SGI-PRO015	Procedura rischio clinico (incident reporting)
TD-SGI-MOD031	Modulo segnalazione infortunio dipendente
TD-SGI-REG004	Regolamento Generale Aziendale (comportamento, disciplina)
TD-SGI-IDL007	Job Description (mansioni esposte al contatto con il pubblico)

3. Definizioni e tipologie di violenza

Ai fini della presente procedura si considerano atti di violenza contro gli operatori sanitari tutte le condotte di pazienti, accompagnatori o soggetti terzi che, nell'ambito dell'accesso ai servizi della struttura, ledano o minaccino l'integrità fisica, psicologica o professionale del personale.

Tipologia	Descrizione	Esempi nel contesto TD
Violenza fisica	Qualsiasi atto intenzionale che provochi un danno fisico all'operatore: percosse, spinte, lancio di oggetti, sputi, graffi, morsi	Paziente che colpisce l'infermiere durante il prelievo; accompagnatore che spinge l'operatore di accettazione; lancio di oggetti al front desk
Violenza verbale	Insulti, urla, minacce, linguaggio offensivo, intimidazioni verbali dirette all'operatore	Paziente che insulta il personale per i tempi di attesa; minacce di denuncia infondate per intimidire; linguaggio sessista o razzista
Minacce	Dichiarazioni esplicite o implicite di voler arrecare danno all'operatore, ai suoi familiari o alla struttura	Fraasi come "ti aspetto fuori", "so dove lavori", "ti faccio chiudere"; minacce con gesti aggressivi
Molestie e stalking	Comportamenti ripetuti e non desiderati che creano disagio, paura o un ambiente ostile per l'operatore	Richieste insistenti di contatti personali; appostamenti fuori dalla sede; messaggi minacciosi ripetuti
Danneggiamento	Atti di vandalismo o distruzione intenzionale di beni della struttura o di oggetti personali dell'operatore	Rottura di vetri, porte, monitor; danneggiamento di apparecchiature; lancio di sedie o attrezzature

4. Analisi del rischio nel contesto di Toscana Diagnostica

4.1 Fattori di rischio specifici

Il rischio di violenza contro gli operatori in Toscana Diagnostica è classificato come medio-basso nell'ambito del DVR (PRO007), in considerazione della tipologia ambulatoriale dei servizi. Tuttavia, l'analisi dei fattori specifici evidenzia situazioni che meritano attenzione e misure dedicate:

Fattore di rischio	Analisi e contesto TD
Tempi di attesa	I ritardi nelle prestazioni, specialmente nei centri diagnostici ad alto flusso (CD Isolotto, CD Sesto) e nei punti prelievo nelle prime ore del mattino, possono generare frustrazione. Il sistema CUP GIPOnext consente la gestione degli appuntamenti, ma le urgenze e le situazioni impreviste possono comunque creare attese
Comunicazione di risultati sfavorevoli	La consegna di referti con risultati anomali o preoccupanti può generare reazioni emotive intense nei pazienti, che possono essere dirette verso il personale di accettazione o verso il medico
Pazienti in condizioni di disagio	Pazienti con dolore, ansia da prelievo, claustrofobia (RM), disagio psichico o sotto effetto di sostanze possono avere reazioni aggressive imprevedibili
Accompagnatori aggressivi	Gli accompagnatori (familiari, caregiver) possono manifestare aggressività per la percezione di scarsa attenzione al proprio congiunto, per i tempi di attesa o per contestazioni sul servizio
Contenzioso economico	Discussioni sul costo delle prestazioni, sulle coperture assicurative, sui ticket o sulle modalità di pagamento possono degenerare in aggressività verbale, soprattutto al front desk
Operatori soli in sede isolata	Il personale dei punti prelievo periferici (Montemurlo, Calenzano, sedi di Livorno) opera talvolta con organico ridotto, aumentando la vulnerabilità in caso di aggressione

4.2 Sedi e aree a maggior rischio

Le aree della struttura identificate come a maggior rischio sono: le accettazioni e i front desk di tutti i centri diagnostici e dei punti prelievo (contatto diretto, gestione code, contenzioso economico); le sale prelievo nei momenti di massimo afflusso (prime ore del mattino); le sale di diagnostica per immagini, in particolare RM (pazienti claustrofobici) e mammografia (pazienti con elevata ansia); le aree di consegna referti; i parcheggi e gli ingressi delle sedi, specialmente nelle ore serali.

5. Misure di prevenzione

5.1 Misure organizzative

Le misure organizzative sono la prima linea di difesa e mirano a eliminare o ridurre le cause che possono generare aggressività:

La gestione degli appuntamenti tramite GIPOnext è ottimizzata per ridurre i tempi di attesa: gli slot sono dimensionati sulla durata effettiva della prestazione, con margini di sicurezza per le situazioni impreviste. La P&C e i responsabili di sede monitorano le anomalie.

La comunicazione con il paziente è proattiva: il personale di accettazione informa il paziente sui tempi di attesa stimati all'arrivo; in caso di ritardi significativi (oltre 15 minuti dall'orario dell'appuntamento), il paziente è aggiornato personalmente.

La consegna dei referti con risultati critici o anomali è gestita dal medico o dal personale formato, in ambiente riservato, con tempo adeguato per le domande del paziente. Il personale di accettazione non consegna referti con risultati critici senza il supporto del medico.

Nelle sedi con organico ridotto (punti prelievo periferici), è garantita la presenza di almeno due operatori durante l'orario di apertura al pubblico. In caso di impossibilità temporanea, il responsabile di rete (Sara Baldacci) attiva la copertura sostitutiva.

I turni sono organizzati in modo da evitare che un operatore resti solo nella struttura durante le fasce orarie di chiusura o in assenza di altro personale.

5.2 Misure strutturali e tecnologiche

Le accettazioni e i front desk sono dotati di banconi con altezza e profondità adeguate a garantire una distanza di sicurezza tra operatore e utente, senza creare barriere comunicative.

Le sedi principali (Laboratorio Sesto, CD Isolotto, CD Belfiore) sono dotate di sistema di videosorveglianza nelle aree comuni (ingressi, sale di attesa, corridoi, parcheggi), in conformità al GDPR e all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, previo accordo sindacale o autorizzazione ITL. I sistemi non riprendono le aree di prestazione sanitaria.

Le accettazioni dispongono di un pulsante di emergenza (allarme antiaggressione) collegato alla sede più vicina o al responsabile di turno. L'attivazione del pulsante genera un alert immediato.

Le sale di attesa sono organizzate con segnaletica chiara, display elimina-code (ove presente) e materiale informativo che descrive i diritti e i doveri del paziente, incluso il rispetto del personale.

L'illuminazione esterna delle sedi è adeguata, in particolare nei parcheggi e negli accessi, per garantire la sicurezza del personale nelle ore di apertura e di chiusura.

5.3 Misure formative

La formazione è il pilastro della prevenzione. Toscana Diagnostica eroga a tutto il personale a contatto con il pubblico un programma formativo specifico articolato nei seguenti moduli:

Modulo formativo	Contenuto	Destinatari e frequenza
Comunicazione efficace e de-escalation	Tecniche di ascolto attivo, gestione del paziente aggressivo, de-escalation verbale, linguaggio corporeo, gestione dello stress relazionale	Tutto il personale front office e sanitario. 4 ore in ingresso (MOD035) + aggiornamento annuale 2 ore (MOD033)
Gestione delle situazioni di emergenza per aggressione	Riconoscimento dei segnali premonitori di aggressione; messa in sicurezza propria e dei colleghi; attivazione dell'allarme; chiamata alle forze dell'ordine; comportamenti da evitare	Tutto il personale. 2 ore in ingresso + aggiornamento biennale 2 ore
Aspetti giuridici e tutele dell'operatore	La L. 113/2020: le aggravanti per l'aggressione a operatori sanitari; come sporgere denuncia; tutela assicurativa e legale offerta da TD; il supporto psicologico aziendale	Tutto il personale. 1 ora in ingresso + informativa annuale
Gestione dei reclami e del contenzioso al front desk	Tecniche per trasformare il reclamo in opportunità; gestione dei pagamenti contestati; quando e come coinvolgere il responsabile; modulistica per la registrazione del reclamo	Personale di accettazione e front office. 2 ore annuali

6. Gestione dell'evento di violenza

6.1 Protocollo di risposta immediata

In caso di atto di violenza o di aggressione in corso, l'operatore e i colleghi presenti seguono il seguente protocollo:

Fase	Azione	Dettaglio operativo
1	Messa in sicurezza	L'operatore si allontana dalla fonte di pericolo. Non tenta di reagire fisicamente. Se possibile, si rifugia in un locale chiudibile o si posiziona dietro una barriera fisica. Mette in sicurezza gli altri pazienti presenti
2	Attivazione dell'allarme	L'operatore preme il pulsante antiaggressione (se disponibile) o chiama il responsabile di sede / il collega più vicino. Se l'aggressione è in corso e la situazione è grave, chiama immediatamente il 112
3	Allontanamento dell'aggressore	Il responsabile di sede o i colleghi intervengono verbalmente per calmare la situazione. Non si tenta di bloccare fisicamente l'aggressore. Se l'aggressore non si calma, si attende l'arrivo delle forze dell'ordine in zona sicura
4	Primo soccorso	Se l'operatore ha subito lesioni fisiche, si attiva il primo soccorso aziendale (PRO008, carrello emergenza MOD020). Se necessario, si chiama il 118
5	Messa in sicurezza della scena	Una volta cessato il pericolo, il responsabile di sede preserva le evidenze dell'evento (non pulisce, non riordina) in attesa delle forze dell'ordine. La videosorveglianza, se presente, conserva le registrazioni
6	Comunicazione interna	Il responsabile di sede informa immediatamente il RSPP, la P&C e la Direzione Sanitaria. L'evento è registrato nel sistema di incident reporting (PRO015)

6.2 Segnalazione e documentazione

Ogni evento di violenza, anche se di lieve entità (violenza verbale, minacce), deve essere segnalato e documentato. La segnalazione avviene attraverso: la compilazione del Modulo Segnalazione Infortunio (MOD031) se l'evento ha causato lesioni fisiche o un'assenza dal lavoro; la compilazione di una scheda di segnalazione specifica per gli eventi senza lesioni (violenza verbale, minacce, danneggiamento), che confluisce nel sistema di incident reporting (PRO015); la registrazione nel DVR (PRO007) per l'aggiornamento della valutazione del rischio da aggressione. La segnalazione è inoltrata alla P&C, al RSPP e al DS entro 24 ore dall'evento.

6.3 Tutela legale dell'operatore

Toscana Diagnostica garantisce all'operatore vittima di violenza il pieno supporto legale: l'azienda si costituisce parte civile nei procedimenti penali derivanti da aggressioni ai propri operatori, in coerenza con lo spirito della L. 113/2020; l'azienda copre le spese legali dell'operatore che decide di sporgere denuncia-querela individuale; l'operatore è assistito nella compilazione della denuncia e nell'espletamento delle formalità; la P&C affianca l'operatore nella comunicazione con l'INAIL per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro.

7. Supporto all'operatore vittima di violenza

L'operatore vittima di un atto di violenza ha diritto a un supporto immediato e a un percorso di accompagnamento che comprende:

Il colloquio di supporto con la funzione P&C entro 24 ore dall'evento, per raccogliere il vissuto dell'operatore, informarlo sui suoi diritti e sulle azioni intraprese dall'azienda.

L'accesso a un supporto psicologico professionale esterno, a carico dell'azienda, per un ciclo di colloqui di elaborazione dell'evento. Il servizio è attivato su richiesta dell'operatore e garantisce la riservatezza.

La possibilità di un periodo di allontanamento temporaneo dalla mansione o dalla sede in cui si è verificato l'evento, con assegnazione a mansione equivalente in altra sede, fino alla risoluzione della situazione.

La sorveglianza sanitaria straordinaria da parte del Medico Competente, per la valutazione dell'idoneità alla mansione dopo l'evento traumatico.

Il follow-up a 30 e 90 giorni da parte della P&C, per verificare il benessere dell'operatore e l'efficacia delle misure adottate.

8. Analisi degli eventi e azioni correttive

Ogni evento di violenza segnalato è sottoposto a un'analisi delle cause e delle circostanze, condotta dal RSPP in collaborazione con la P&C e il responsabile della sede coinvolta. L'analisi esamina: le cause prossime dell'evento (cosa ha scatenato l'aggressione); le cause remote (carenze organizzative, strutturali o formative che hanno contribuito); l'efficacia delle misure di prevenzione in atto; le azioni correttive necessarie (organizzative, strutturali, formative, disciplinari).

Gli eventi di violenza sono riesaminati in forma aggregata con cadenza semestrale dalla P&C, dal RSPP e dal DS. Il riesame analizza i trend, identifica le sedi e le circostanze più frequenti e propone azioni di miglioramento sistemiche. I risultati confluiscono nel Riesame della Direzione (PRO002).

9. Provvedimenti nei confronti dell'aggressore

Toscana Diagnostica adotta un approccio di tolleranza zero verso qualsiasi forma di violenza nei confronti del proprio personale. I provvedimenti nei confronti dell'aggressore comprendono:

Per i pazienti: l'allontanamento immediato dalla struttura in caso di aggressione in corso; la comunicazione scritta con avvertimento formale in caso di violenza verbale o minacce; nei casi gravi o recidivi, il divieto di accesso alla struttura (salvo prestazioni urgenti non differibili) comunicato per iscritto al paziente, alla ASL e, se del caso, all'Ordine del medico curante.

Per gli accompagnatori: l'allontanamento immediato dalla struttura; il divieto di accompagnamento nei casi recidivi.

Per il personale dipendente TD (violenza tra colleghi): l'attivazione del procedimento disciplinare (REG004 Sez. 12), con le sanzioni proporzionate alla gravità dell'evento, fino al licenziamento per giusta causa.

In tutti i casi di violenza fisica: la denuncia alle autorità competenti, con supporto legale dell'azienda all'operatore.

10. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	AD	P&C	RSPP	DS	Resp. sede	Operatore	IT
Valutazione rischio aggressione (DVR)	A	C	R	C	C	I	I
Misure strutturali (videosorveglianza, allarmi)	A	I	C	I	C	I	R
Formazione de-escalation	I	R	C	I	I	R	I
Messa in sicurezza immediata	I	I	I	I	R	R	I
Chiamata forze dell'ordine / 112	I	I	I	I	R	R	I
Segnalazione evento (MOD031 / PRO015)	I	R	R	I	C	R	I
Supporto psicologico all'operatore	I	R	I	C	I	I	I
Tutela legale e denuncia	A	R	C	C	I	I	I
Analisi cause e azioni correttive	I	C	R	C	C	I	I
Riesame semestrale eventi	A	R	R	C	I	I	I
Provvedimenti verso aggressore	A	R	C	C	C	I	I

11. Indicatori di processo

Eventi di violenza segnalati per semestre: Monitoraggio trend (obiettivo: riduzione progressiva).

Personale formato su de-escalation nell'anno: Obiettivo: 100% del personale a contatto con il pubblico.

Tempo medio di risposta all'evento (dalla segnalazione all'attivazione del supporto): Obiettivo: entro 24 ore.

Segnalazioni documentate e archiviate correttamente: Obiettivo: 100%.

Follow-up a 30 e 90 giorni completati: Obiettivo: 100% degli operatori coinvolti.

Azioni correttive completate entro i termini stabiliti: Obiettivo: 90% o più.

Riesame semestrale presentato al Riesame della Direzione: Obiettivo: Sì, due volte all'anno.

Operatori che hanno usufruito del supporto psicologico su totale coinvolti: Monitoraggio (offerta proattiva).

12. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani